

Vanessa e lucas

Pré Perguntas:

Diferenciação de Perfis e Permissões (RBAC)

- **Pergunta:** "Quais são os papéis de usuário que utilizarão o sistema (ex: Recepcionista, Médico, Administrador, Assistente Social) e, especificamente, **quais informações cada perfil não deve ter permissão para visualizar?**"
- **Contexto Técnico:** Isso define a estrutura de controle de acesso baseada em funções no banco de dados.

Recepcionista, secretária, auxiliar administrativo, coordenação, médicos, terapeutas e paciente/responsável.

Recepção faz a parte de recepção, secretaria e auxiliar administrativo. Marca presença do presente, agendamento (marcar, agendar e desmarcar).

A Secretaria faz a matrícula do paciente (banco de dados).

O acesso da coordenadora (Vanessa) deve ser geral, ter acesso a tudo.

Cartão do SUS, CID, idade. Identificação/diferenciação do paciente pela data de nascimento e nome da mãe.

Endereço, alergia, medicação.

Dois serviços, municipal (da saúde) e federal (CER) - intelectual, dois convênios diferentes.

Nome da escola e se é regular (municipal, estadual) ou de educação especial (específica para a condição do paciente).

Hipertensão, alergias, condições prévias do paciente.

Tem convênio ou não? (é informação útil, mas não afeta o atendimento)

O meio de transporte do paciente é registrado.

Se cada paciente tiver um número de registro/de matrícula, para ajudar na recepção deles, porque o processo atual é bem complicado.

A solicitação de atestados e declaração de horas pode ser melhor. Exemplo: implementar uma função no sistema para imprimir a solicitação, que puxa os dados do sistema, conforme a consulta, nome do médico, horas ausente, CID.

Regras de Negócio e Automação de Fila

- **Pergunta:** Além da ordem de chegada, existem critérios legais (como idade ou prioridade por lei) ou de gravidade clínica que o sistema deve usar para **calcular a posição na fila automaticamente?**
- **Objetivo:** Transformar "regras ocultas" em algoritmos de ordenação no banco de dados.

A própria regulação de vagas faz isso (municipal e federal).

Quando já é paciente da APAE, os pacientes ligam e a recepção remarca a consulta.

Formatos e Prazos de Saída de Dados (SUS)

- **Pergunta:** "Para os relatórios entregues ao SUS, existem **formatos de arquivo específicos** exigidos pelo governo (como arquivos XML para o sistema SIA/SUS ou PDFs com assinatura digital)? Além disso, quais são os **prazos rígidos** para o envio desses dados?"
- **Contexto Técnico:** Define os requisitos de exportação de dados e geração de arquivos do backend.

Os relatórios são feitos no formato do da psicologia. (precisamos ver qual é)

Definição de Campos e Artefatos (Agenda)

- **Pergunta:** Ao olharmos para seus modelos de agenda atuais, quais campos são **estritamente obrigatórios** para salvar um agendamento e quais são apenas informais/opcionais?
- **Objetivo:** Determinar a obrigatoriedade (NOT NULL) das colunas nas tabelas SQL de agendamento.

Cartão SUS (**), nome, data de nascimento e setor do paciente, nome da mãe, CPF.

Critérios de Sucesso e Valor de Entrega

- **Pergunta:** Para os gestores e usuários, quais resultados definiriam que a implementação do GISA foi um **sucesso** (ex: redução de 50% no tempo de triagem ou fim do uso de papel)?
- **Objetivo:** Alinhar as expectativas dos *stakeholders* com as funcionalidades entregues pelo software.

registro interno, diminuir o que o paciente vê, explicação melhor de documentos.

6. Proteção de Dados Sensíveis (LGPD)

- **Pergunta:** Quais dados armazenados são considerados **sensíveis** (ex: diagnósticos, situação socioeconômica) e como é feita a proteção deles hoje?
- **Objetivo:** Garantir que o sistema GISA esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Na prestação de contas, é feito manualmente.

Os prontuários dos pacientes são protegidos por cadeado. Quando os pacientes ou responsáveis solicitam a cópia do prontuário, há um processo de liberação mediante assinatura.

Auditoria e Histórico de Alterações (Logs)

Em sistemas de saúde, saber *quem* alterou o *quê* é uma exigência de segurança e conformidade.

- **Pergunta:** "Quais ações no sistema devem gerar um rastro de auditoria obrigatório (ex: alteração de diagnóstico, exclusão de agendamento ou visualização de prontuário)?"
- **Pergunta Correlativa:** "Por quanto tempo o histórico de logs de acesso a dados sensíveis deve ser armazenado para fins de auditoria interna?"
- **Contexto Técnico:** Criação de tabelas de LOG_SISTEMA para registrar USER_ID, ACTION, TIMESTAMP e OLD_VALUE/NEW_VALUE.

no papel prefeitura

Perguntas 24/03/2026

- 1) De que forma vocês recebem o paciente encaminhado do SUS para cadastro? É por meio digital ou físico?
 - (SE HOUVER ALGUM SITE) Vocês poderiam me mostrar o meio?
- 2) Qual a frequência que vocês recebem um novo paciente?
100/mes federal cer 10/mes município
- 3) Há algum processo imediato que acontece após o cadastro do paciente?
avaliação/triagem
- 4) Tem algum tipo de relatório a ser entregue para o SUS?
 - Tem algum modelo que possa ser disponibilizado?
repassa doc do sus
- 5) Quais tipos de atendimentos são feitos? (Ex: Atividades, Acompanhamentos, Clínicos, etc).
 - **Tentar deixar o mais esclarecido possível o funcionamento de cada atendimento. Perguntar tipos de atividades, tipos de acompanhamentos, etc.**
 - Como vocês fazem/gostariam a organização dos tipos de atividades? (Ex: por área)
 - Quais os critérios para acompanhar a evolução do paciente? Qual o meio oficial usado pela APAE?

Descrição de como o paciente chegou, estado geral. Pontuação, escalas (6 meses). É interessante que haja um campo de descrição para colocar informações gerais sobre o paciente, se foi dispensado por algum motivo (febre, doença), quais atividades fez na terapia, etc.

Também seria bom um botão para impressão deste documento (mas não tão completo) da consulta (com o timbrado da APAE), mais para o paciente, mas também necessário manter no prontuário (para fiscalização da prefeitura).

Os gráficos que aparecem para os pacientes não são tão necessários para eles, mas para os terapeutas será excelente.

- **Há algum modelo de registro de consultas/atividades/acompanhamentos que possa ser disponibilizado?**
- O que muda em um retorno de atendimento?

depende do médico, pode ser um retorno de 2 meses etc.

quando já teve a primeira consulta com eles, não muda nada.

no primeiro dia da consulta/triagem de avaliação, há a assinatura no papel do SUS (Guia de Encaminhamento), e só depois disso os pacientes são cadastrados como pacientes da APAE.

Ao invés de utilizar o termo “atividade”, é preferível terapia.

- 6) Como funciona o processo de remarcar e cancelar um atendimento?
whatsapp paciente
remarcação pode ser feita, mas é necessária uma comprovação/atestado para justificar a ausência do paciente (atestado médico/odontológico ou declaração escolar - este não é cobrado pela prefeitura), que fica no prontuário.
- 7) Quais os campos clínicos que a APAE atende e que pretendem atender?
Para esclarecer o escopo.
Educação, saúde, assistência
- 8) Os documentos, como exames, são guardados por vocês ou permanecem com os pacientes?
paciente para eles, guarda, resto para o paciente
- 9) Qual a diferença de um médico PJ para um médico contratado? Quais aspectos a serem considerados?
- Qual a influência do médico PJ em sua própria/geral escala?
pj define horário possível apae decide
exemplo: médico pj pode das 8h às 12h na sexta-feira, ele envia essa informação para a secretária ou coordenação, agenda é a APAE que monta
- 10) Como é organizada a escala de cada médico?
- Quais os aspectos a serem considerados para o médico PJ?
escala apae
- 11) Há algum modelo de agenda que possa ser disponibilizado? (Ex: Excel)

Possíveis resposta/Perguntas extras:

1. Fluxo de Recebimento e Triagem

- **Possível Resposta:** O encaminhamento chega via guia física da Central de Regulação do SUS, mas os dados são inseridos manualmente no sistema interno para gerar o prontuário digital.
- **Pergunta Correlativa:** O sistema GISA deve prever um módulo de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) para digitalizar essas guias ou haverá integração via API com o sistema municipal de saúde?

já tem

2. Organização da Fila e Priorização

- **Possível Resposta:** Atualmente, a fila é organizada por ordem cronológica de chegada, sem categorias de prioridade técnica pré-definidas no primeiro contato.
- **Pergunta Correlativa:** Para otimizar a gestão, o sistema deve implementar um sistema de "Score de Vulnerabilidade" ou "Gravidade Clínica" para sugerir uma reordenação da fila baseada em critérios médicos?

6 meses com score fora isso texto (PTS Projeto Terapêutico Singular - para evolução clínica)

3. Gestão de Atendimentos e Evolução

- **Possível Resposta:** Os atendimentos são divididos em eixos (Clínico, Pedagógico e Social). A evolução é registrada de forma textual em fichas individuais de cada especialidade.
- **Pergunta Correlativa:** Como o GISA deve estruturar o banco de dados para permitir uma "Visão 360º", onde o psicólogo consiga visualizar (com permissão) o progresso registrado pelo fisioterapeuta no mesmo período?

completo

exemplo: um terapeuta viu algo num paciente, o médico viu outra coisa, então os profissionais se reúnem para debater o caso de um paciente e buscar a melhor conduta possível.

4. Relatórios e Conformidade com o SUS

- **Possível Resposta:** É necessário entregar mensalmente o BPA (Boletim de Produção Ambulatorial) para o SUS para fins de faturamento e comprovação de metas.
- **Pergunta Correlativa:** O sistema GISA terá um gerador automático de arquivos no formato exigido pelo SIA/SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais) para evitar erros de digitação manual?

não

5. Escala Médica e Profissionais PJ

- **Possível Resposta:** Médicos PJ possuem horários mais flexíveis e sua escala é gerada mensalmente com base em sua disponibilidade contratual, diferentemente dos celetistas que possuem grade fixa.
- **Pergunta Correlativa:** Devemos criar uma funcionalidade de "Portal do Profissional" onde o médico PJ possa sinalizar seus impedimentos de agenda diretamente no sistema antes da montagem da grade mensal?

6. Armazenamento de Documentos e Exames

- **Possível Resposta:** Exames de imagem originais permanecem com o paciente, mas a APAE guarda cópias dos laudos em pastas físicas para histórico de tratamento.
- **Pergunta Correlativa:** Haverá suporte para armazenamento de anexos (PDF/Imagens) no prontuário eletrônico para eliminar a necessidade dessas pastas físicas e garantir a segurança dos dados (LGPD)?

7. Processo de Remarcar e Cancelar Atendimentos

- **Possível Resposta:** Atualmente, o cancelamento é feito por telefone ou presencialmente, e a vaga é preenchida manualmente chamando o próximo da lista de espera ou oferecendo a um paciente que já está na unidade para uma sessão extra.
- **Pergunta Correlativa (Foco em Backend):** O sistema GISA deve implementar uma regra de negócio que automatiza a fila de "vagas remanescentes", enviando uma notificação via sistema ou SMS para o próximo da fila assim que uma desmarcação for confirmada?

interno, médico ou família pede, não é bom cancelar agenda

8. Campos Clínicos e Escopo de Atendimento

- **Possível Resposta:** A APAE atende Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Neuropediatria. Pretende-se expandir para Psiquiatria e Nutrição especializada para autismo.
- **Pergunta Correlativa (Foco em Banco de Dados):** Como estruturar as tabelas de ESPECIALIDADE e ATENDIMENTO de forma que o sistema seja escalável para novos campos clínicos sem a necessidade de alterar o esquema do banco de dados (DDS) no futuro?

por enquanto não, previamente

9. Gestão de Exames e Documentos Médicos

- **Possível Resposta:** Os exames físicos permanecem com o paciente, mas a APAE precisa manter cópias ou digitalizações dos laudos para embasar o Plano de Atendimento Individual (PAI).
- **Pergunta Correlativa (Foco em Segurança/Privacidade):** Para o projeto GISA, qual será a política de criptografia de arquivos para esses exames, garantindo que apenas profissionais vinculados ao caso do paciente tenham acesso aos anexos sensíveis?

10. Diferença entre Médico PJ e Contratado

- **Possível Resposta:** O médico contratado (CLT) possui carga horária fixa e dedicação exclusiva à grade da instituição, enquanto o médico PJ atua como prestador de serviço, tendo maior autonomia sobre sua escala externa, o que exige um controle de agenda mais flexível.
- **Pergunta Correlativa (Foco em Lógica de Negócio):** O módulo de RH do sistema deve tratar os pagamentos de forma distinta (salário fixo vs. horas prestadas/produtividade)? Como o sistema calculará o repasse para o médico PJ baseado nos atendimentos realizados?

a agenda dos médicos PJ é definida por eles, eles passam o horário disponível e a APAE faz o agendamento dos pacientes.

número do CBO para as diferentes especialidades.

11. Organização da Escala e Aspectos do Médico PJ

- **Possível Resposta:** A escala é organizada mensalmente tentando conciliar as salas disponíveis na APAE com a disponibilidade dos médicos. Para o PJ, deve-se considerar que ele pode ter outros vínculos hospitalares, o que gera maior rotatividade de horários.
- **Pergunta Correlativa (Foco em Algoritmo):** Seria viável implementar um algoritmo de "Match de Agenda" que cruza a disponibilidade do profissional PJ com a disponibilidade do paciente e da sala física, evitando conflitos de reserva no banco de dados?

O agendamento para uma terapia apresenta regularidade. Exemplo: paciente X é sempre atendido pela psicóloga Y no mesmo dia da semana e horário. Colocar a opção de repetir os mesmos dias da semana e horário para o retorno, para o agendamento do paciente.

Manter o status do paciente é interessante, se foi recepcionado, se está em atendimento, se já foi embora.

No perfil de agendamento do paciente, fazer a busca por profissional e horário disponível.

12. Modelo de Agenda (Excel e outros)

- **Possível Resposta:** Hoje a gestão é feita via planilhas de Excel separadas por profissional, o que dificulta a visão consolidada da ocupação da unidade e gera erros de duplicidade.
- **Pergunta Correlativa (Foco em UI/UX e Dados):** O sistema GISA deve permitir a importação de dados dessas planilhas legadas (formato .csv ou .xlsx) para povoar o banco de dados inicial sem perda de histórico de agendamentos?

doc recentes

extras: chatbot para whatsapp, para avisar pacientes e responsáveis sobre a consulta agendada.

14h10 - 15h40

Visita Mensal?

Acompanhamento do processo?
pode gravar.

encaminhamento CER não vem com contrarreferência, então eles têm que fazer um documento próprio para enviar para o sistema federal, o do SUS já vem com.